

社区护理干预对老年性痴呆患者生存质量的影响

王卓, 慕江兵, 刘蕊, 王红霞

摘要: [目的] 探讨社区护理干预对老年性痴呆患者生存质量的影响。[方法] 将社区中 80 例早、中期老年性痴呆患者随机分为对照组、干预组各 40 例。对照组进行常规家庭护理, 不实施干预措施。干预组实行社区护理干预: 包括健康知识宣教; 基础生活护理; 心理情感支持; 康复训练指导。应用健康状况调查问卷 (SF-36)、简易精神状态检查表 (CMMSE) 和日常生活能力量表 (ADL) 进行评估。[结果] 干预后 1 年, 干预组的 SF-36 量表和 CMMSE 量表分值明显较对照组及干预前升高 ($P < 0.05$), ADL 量表分值低于对照组及干预前 ($P < 0.05$)。[结论] 社区护理干预能够延缓老年性痴呆患者的病程, 减轻症状, 改善生存质量。

关键词: 社区护理; 老年性痴呆; 生存质量

COMMUNITY NURSING INTERVENTION ON QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH SENILE DEMENTIA WANG Zhuo, MU Jiang-bing, LIU Rui, et al. (Nursing School, Liaoning Medical College, Jinzhou 121000, China)

Abstract: [Objective] To investigate the impact of community nursing intervention on senile dementia patients' quality of life. [Methods] 80 patients with early and mid-senile dementia in the community were randomly divided into control group and intervention group, each group 40 cases. Control group: carried out routine home care, no implementation of interventions. Intervention group: including health knowledge education; the basic living care; psychological emotional support; rehabilitation training guide. Utilized 36-items short form health survey (SF-36), Chinese Mini Mental State Examination (CMMSE) and activities of daily living scale (ADL) to assess. [Results] 1 year after the intervention, the scores from SF-36 scale and CMMSE Scale in intervention group were significantly higher than the control group and before intervention ($P < 0.05$), score from ADL scale was lower than the control group and before intervention ($P < 0.05$). [Conclusion] Community nursing intervention could slow the course of senile dementia patients, reduce symptoms and improve quality of life.

Key words: Community care; Senile dementia; Quality of life

老年性痴呆即阿尔茨海默病 (Alzheimer's Disease 老年痴呆) 是一种随着时间推移而渐进的神经系统疾病, 患者的生活能力和社会功能呈难以逆转的损害^[1]。流行病学调查表明: 65 岁以上老年痴呆患病率达 3%~8%, 80 岁以上增加到 30% 或更高, 该病已成为现代社会老年人的主要致死疾病之一^[2]。目前, 我国 AD 患者大部分是在家中由家庭照顾者照料, 但大多数照顾者缺乏本病的相关知识和护理常规技术, 导致病情逐渐恶化, 严重影响到患者的生存质量, 并给家庭和社会带来了沉重负担, 成为不可忽视的社会公共卫生难题。因此, 社区护理人员有责任和义务承担起这一重任, 积极采取有效的干预措施, 帮助家庭照顾者提高 AD 患者的生存质量。为了探讨社区护理干预对 AD 患者生存质量提高的效果, 笔者于 2007 年 5 月~2008 年 5 月对锦州市松坡园社区和西劳保社区中 80 例诊断为早、中期 AD 患者随机分组, 实施不同社区护理干预, 进行对比观察及效果分析。

基金项目: 辽宁省“十一五”教育科学规划课题, 立项编号第 58-4 项

作者简介: 王卓 (1982-), 本科, 助教

通讯作者: 慕江兵, 副主任护师, Tel: 13840608093

作者单位: 辽宁医学院护理学院, 锦州, 121000

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择社区中 80 例医院诊断为 AD 患者, 入选标准符合美国精神疾病诊断和统计手册 (DSM-IV) 中 AD 的诊断标准, 临床痴呆评定量表 (CDR) 评定为早、中期的 AD 患者。其中男 42 例, 女 38 例, 年龄 60~88 岁, 文化程度: 文盲 18 例, 小学 24 例, 初中 22 例, 高中以上 16 例。随机分为干预组 40 例 (早、中期各 20 例), 对照组 40 例 (早、中期各 20 例)。两组性别比、年龄、文化程度、病程、痴呆评定、量表评定比较差异无统计学意义 ($P > 0.05$)。

1.2 方法

对照组仅给常规家庭护理指导, 干预组开展全面、综合的社区护理。

1.2.1 健康知识宣教 社区护理人员根据 AD 患者及家属健康知识需求, 定期开展知识讲座, 发放 AD 患者及照顾者健康教育和康复指导手册, 并详细讲解, 使其理解掌握, 能够简单复述宣教内容; 每周电话访问 1 次, 倾听患者及家属的问题, 建立良好的护患关系, 取得患者信任; 每个月家庭访视 1 次, 现场进行健康教育宣传及护理技术指导, 为期 1 年。

1.2.2 基础生活护理 ① 基础护理: 实施“无缝医疗保健”^[3], 社区护理人员与家属共同讨论确定患者在家中适合的照料方式。给予患者细心的呵护, 安排合理的作息时间, 保证良好的

睡眠质量;保持皮肤清洁,衣物洁净,注意保暖,预防皮肤及肺部等各系统的感染;按时服药,促进疾病恢复;根据身体状况,做适当的户外运动,锻炼身体,增强体质。②安全护理:家里地面不宜过于光滑,必要时在盥洗室等处安扶手,防止患者跌倒;行动困难患者如厕、洗浴要有人陪伴,以防意外发生;家中锐器物品、药品妥善放置,避免患者自伤或误服;易走失的患者,随身携带与家人联系的卡片,避免单独外出,防止丢失迷路。③饮食护理:一日三餐定时定量,饥饱适宜,膳食搭配合理,以清淡营养丰富为主,多食豆类、奶类、瘦肉、蔬菜、海鲜、粗纤维等食物,保证优质蛋白质、多不饱和脂肪酸及维生素等营养素的摄取。

1.2.3 心理情感支持 全面评估患者,根据其性格特征,采取个性化护理,充分体现“以人为本”。定期为患者做心理情感咨询,了解患者的心理情绪状态,减少患者因情绪异常引起行为问题的发生。鼓励患者参加力所能及的家庭社会活动,如看书、读报、听广播、种花、下棋、打球、参加社区老人联谊会等,以分散注意力,排遣不良情绪,增加交流,提高沟通能力,使其感受到生活的乐趣及自身价值,促进心理健康。指导照顾者掌握与老年痴呆患者交流的方法,用理解、宽容,诚恳的态度对待病人,耐心听取病人的诉说,细心观察患者的情绪变化,尽量满足其合理要求;成立社区老年痴呆患者照顾者病友会,提供照顾者之间分享照顾技巧的途径,同时有助于减轻照顾者的照顾感受压力。

1.2.4 康复训练指导 ①益智训练:减缓记忆、智能衰退,指导家属要经常提醒患者日期、时间、地址、家中电话号码等信息,鼓励患者对往事的回忆,要不厌其烦,帮助其强化近期记忆和激发远期记忆。让患者做一些简单的数字排列和运算,识图,折纸等活动,每日不少于 30 min。组织患者参加适宜的集体活动,增强其自信心,促进计算,判断,思维,理解等认知能力及语言能力的恢复。②日常生活能力训练:根据患者自理能力,选择力所能及的生活内容进行训练。自理能力较好的患者,尽量让其自己完成做饭、吃饭、穿衣、洗漱、洗澡、打扫房间等日常生活,四肢关节经常活动能够保持手脚灵活,促进血液循环;自理能力较差的患者,家属协助其完成复杂的生活活动,并做好肢体功能康复训练。

1.3 评价标准

对社区 80 例早、中期 AD 患者,分别于干预前和干预 1 年后的前 1 周,应用健康状况调查问卷(SF-36)、简易精神状态检查表(CMMSE)和日常生活能力量表(ADL)进行评估。

2 结果

应用 SPSS13.0 软件进行统计分析,所有计量资料均用 $\bar{x} \pm s$ 表示,采用 t 检验, $P < 0.05$ 为差异有统计学意义,结果见表 1~3。

表 1 健康状况调查问卷(SF-36)

组别	例数	干预前	干预后(1年)	t 值	P 值
干预组	40	430 ± 132	528 ± 146	-3.15	< 0.05
对照组	40	435 ± 148	427 ± 171		
t 值		-0.16	2.84		
P 值		> 0.05	< 0.05		

3 讨论

表 2 简易精神状态检查表(CMMSE)

组别	例数	干预前	干预后(1年)	t 值	P 值
干预组	40	19.21 ± 3.93	21.02 ± 3.88	-2.08	< 0.05
对照组	40	19.48 ± 2.84	18.50 ± 3.10		
t 值		-0.35	3.19		
P 值		> 0.05	< 0.05		

表 3 日常生活能力量表(ADL)

组别	例数	干预前	干预后(1年)	t 值	P 值
干预组	40	20.9 ± 1.9	19.4 ± 1.8	3.66	< 0.05
对照组	40	20.6 ± 1.8	20.3 ± 1.7		
t 值		0.73	-2.31		
P 值		> 0.05	< 0.05		

AD 是一种慢性渐进性退化痴呆,以缓慢进展的智力减退为特征,最终导致无力进行日常生活和人格的持续变化^[4]。若得不到悉心护理,患者的生存期限会明显缩短。然而大多数患者及家属对 AD 的护理知识缺乏,致使患者在家庭中难以得到正规的、系统的康复护理^[5]。因此我们对 AD 患者通过 1 年的社区护理干预,主要是为了提高患者的生存质量,让其减少对别人的依赖,使其保持一种自我感和归属感,增强在居住地的控制力。表 1 显示,干预后患者的健康状况明显得到改善,调查评分高于对照组及干预前, $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。由此可见,社区护理人员在患者疾病的恢复中起着举足轻重的作用。开展社区健康教育是必不可少的,有利于 AD 患者及家属对疾病的正确认识,掌握基本的保健知识。走进家庭,指导 AD 患者的治疗、护理,既优化了卫生资源,减轻了社会家庭的经济负担,又可提供个体化的医疗护理服务,改善了患者的生理机能、生理职能、躯体疼痛等健康状况。表 2 显示,干预后患者的情绪状态、记忆及认知能力显著提高,调查分值高于对照组及干预前, $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。应用心理情感支持,社区护理人员能够了解 AD 患者的心理状态,有针对性的进行心理疏导,减轻患者的焦虑、抑郁等负性情绪,使其从容应对生活中的压力。采用益智训练,延缓了患者记忆、认知等能力的减退,保持大部分患者的智能水平,使其增强自信心。表 3 显示,干预后患者的日常生活能力得到很大的提高,调查评分低于对照组和干预前, $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。通过对 AD 患者日常生活能力的康复训练,注重发挥社会功能和家庭功能,培养患者的自理能力,鼓励患者做力所能及的事,使患者在自我护理中体会到了生存的价值,延缓了生命进程。

综上所述,社区护理干预在提高 AD 患者的生存质量方面起着至关重要的作用。为此,我们应充分发挥社区护理工作的职能,投入足够的卫生服务资源,建立完善的社区老年服务体系,动员全社会人来了解、关爱老年痴呆患者,提高其生存质量。

参考文献:

- [1] Lopez OL, Becker JT. Factors que modificanel curso natural de la enfermedad de Alzheimer [T]. Review Neurology, 2003, 37 (2): 149-55.
- [2] 王鲁宁. 关注老年痴呆患者的照料者问题 [J]. 中华内科杂志, 2006, 45 (4): 69-71.
- [3] 温贤秀. 面向社会的家庭化护理 [J]. 国外医学·医学分册, 1995, (下转第 844 页)

没有得到很好的控制 (见表 2)。经 6 个月~1 年的干预后, 糖尿病人血糖降低, 血压、体重指数等指标均有不同程度的改善, 症状减轻, 缓解率增加, 生存质量提高 (见表 5)。运动疗法干预糖尿病人措施有效。

表 3 文昌社区知识调查结果 ($\times 10^{-2}$, $\bar{x} \pm s$)

知识项	n (例)	错误回答率
基础知识	300	26.7 ± 1.2
饮食控制	300	25.9 ± 0.9
用药情况	300	40.4 ± 1.8
运动疗法	300	70.3 ± 0.8
心理检测	300	25.7 ± 0.7
知识教育	300	43.3 ± 1.7

表 4 干预 6 个月后文昌社区一般资料调查结果 ($\bar{x} \pm s$)

组别	n (例)	并发症 (例)	BMI	血糖 (mmol/L)	血压 (mm Hg)
糖尿病人	150	5	23.26 ± 3.89	7.60 ± 2.80	130.20 ± 11.12
糖尿病人家属	90	0	25.50 ± 3.37	6.12 ± 2.20	130.88 ± 12.24
一般人群	60	0	23.30 ± 3.38	6.08 ± 2.12	127.20 ± 11.29

表 5 干预 1 年后文昌社区一般资料调查结果

组别	n (例)	并发症 (例)	BMI	血糖 (mmol/L)	血压 (mm Hg)
糖尿病人	150	4	23.25 ± 3.80	7.59 ± 2.81	125.21 ± 11.11
糖尿病人家属	90	0	22.10 ± 3.20	6.08 ± 2.21	130.87 ± 10.24
一般人群	60	0	22.30 ± 3.18	6.07 ± 2.02	127.15 ± 10.22

表 6 糖尿病人干预前后血糖、血压、BMI 指数变化情况

时间	BMI	血糖 (mmol/L)	血压 (mm Hg)
干预前	26.6 ± 3.70	7.78 ± 2.74	131.95 ± 14.67
干预后 (6 个月)	23.26 ± 3.89	7.60 ± 2.80	130.20 ± 11.12
干预后 (1 年)	23.25 ± 3.80	7.59 ± 2.81	125.21 ± 11.11
P 值	< 0.05	> 0.05	< 0.05

积极推行糖尿病的运动疗法, 并在糖尿病三级预防工作中加以强化。通过三级预防引导人们提高对运动疗法的认识, 增强人们的防病意识, 并通过积极有效的护理干预使人们学会使用正确的运动方式, 养成长期规则的运动习惯, 三级预防在社区糖尿病运动疗法中的应用是控制糖尿病发病率, 降低并发症发生的有力措施和手段。

参考文献:

[1] 高旗. 糖尿病运动疗法对血糖的影响 [J]. 中国误诊学杂志,

3 讨论

糖尿病是一种多病因的非传染性流行病, 也是一种终生携带的疾病, 其并发症极大地增加了该病人群的致残率、致死率, 严重影响病人的身心健康和生活质量。国际糖尿病研究所主任齐默尔教授说: “糖尿病流行可能较艾滋病的危害更大。”目前研究和实践已经证明, 至少 80% 的心脏病、中风和糖尿病是可以预防的。运动疗法是一种积极有效的控制血糖的方法, 适宜适时, 持之以恒的运动, 有助于控制血糖, 改善代谢, 减轻体重, 降低血压, 这对预防和改善糖尿病并发症非常重要, 同时运动有助于增强体质, 改善精神状态, 提高生存质量, 在社区中开展糖尿病运动疗法是可行有效的^[4]。然而, 目前我国糖尿病的防治宣传教育还比较薄弱, 群众的自我保健意识还比较差^[5]。运动疗法还未引起人们的足够认识, 在一定程度上影响了糖尿病的预防和预后^[6]。根据健康状态的自然过程, 糖尿病的防治机会存在于 3 个不同时期, 即通过三级预防来实现^[7]。

2007, 7 (12): 2720-2722.

- [2] 孟共林, 宋小花, 李香莉. 糖尿病病人运动疗法实施研究与护理进展 [J]. 中国护理管理, 2008, 8 (8): 41-43.
- [3] 吴毅, 吴军发. 运动疗法在糖尿病预防和治疗中的作用 [J]. 中国康复医学杂志, 2007, 22 (5): 335-337.
- [4] 孙哈潇, 吴辉, 王烈. 老年 2 型糖尿病患者社区健康管理研究 [J]. 中国医科大学学报, 2008, 37 (4): 532-534.
- [5] 沈雁红, 吴毅. 运动疗法对社区糖尿病患者血糖的影响 [J]. 中国康复医学杂志, 2009, 24 (11): 1028-1029.
- [6] 崔军, 张涛, 张莉娜, 等. 宁波市社区 343 例 2 型糖尿病患者综合治疗情况调查 [J]. 中国慢性病预防与控制, 2007, 15 (6): 586-588.
- [7] 王萍, 梁仁瑞, 韩俏英, 等. 运动处方护理干预对社区 2 型糖尿病病人血糖、血脂的影响 [J]. 护理研究, 2009, 23 (5): 1405-1408.
- [8] 刘艳. 运动疗法对糖尿病患者血糖的影响 [J]. 中国误诊学杂志, 2008, 8 (26): 6354-6356.

(收稿日期: 2009-09-20)

(上接第 841 页)

14 (2): 63.

[4] 张月华, 卢少萍, 符霞, 等. 老年性痴呆病人家属健康教育需求的研究 [J]. 护理学杂志, 2003, 18: 542.

[5] 张淑菊, 贾京绵, 李艳欣, 等. 社区卫生干预对老年性痴呆患者生存质量影响的相关性研究 [J]. 河北医药, 2008, 3 (3): 388-389.

(收稿日期: 2009-09-20)